

Patient's Name : _____

MRN : _____

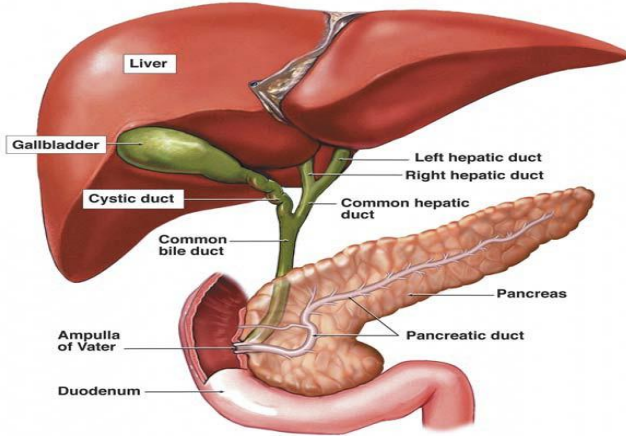
DoB: _____

Consent Information - Patient's Copy ERCP (Gastroendoscopy)

معلومات الإقرار – نسخة المريض
التصوير المعدي لفتحات المرارة والبنكرياس

1. What is an ERCP (Gastroendoscopy)?

An ERCP is where the doctor examines the ducts of your liver, pancreas and gallbladder. This is done by giving you some medication to help you relax. You will lie on the x-ray table on your tummy. The doctor will pass the endoscope, which is a thin, black flexible tube with a camera attached which allows the doctor to see the pictures as it is passed through your mouth, food pipe, stomach and into the first part of the small bowel. A fine plastic tube will be passed down the endoscope and into the ducts of the liver and pancreas. A contrast material (dye) will be injected into the ducts and x-rays will be taken. During the procedure, the doctor may remove stones and relieve the duct blockage. This procedure may or may not require a sedation anaesthetic.



2. Will there be any discomfort? Is any anaesthetic needed?

The procedure can be uncomfortable and to make the procedure more comfortable a sedative injection or a light anaesthetic may be given. You may be changed from a sedation anaesthetic to a general anaesthetic. Before all endoscopy procedures begin, the doctor will insert a drip into a vein in your hand or forearm. This is where the sedation or anaesthetic is injected.

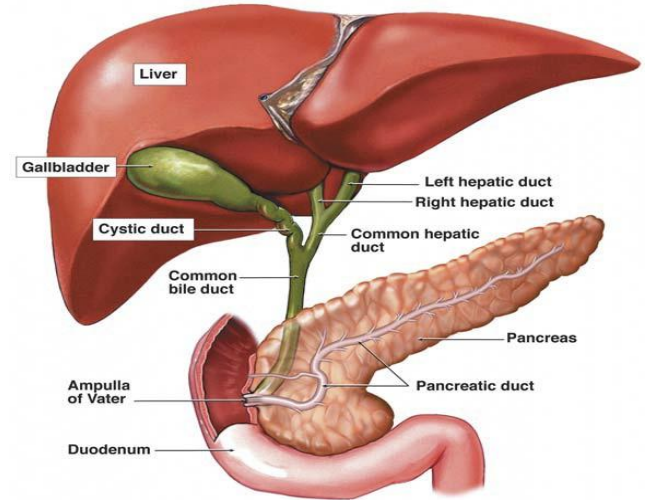
3. What is sedation?

Sedation is the use of drugs that give you a 'sleepy-like' feeling. It makes you feel very relaxed during a procedure that may be otherwise unpleasant or painful.

You may remember some or little about what has occurred during the procedure. Anaesthesia is generally very safe but every anaesthetic has a risk of side effects and complications. Whilst these are usually temporary, some of them may cause long-term problems.

1. ما هو التصوير المعدي لفتحات المرارة والبنكرياس ؟

في هذا الإجراء يفحص الطبيب قنوات الكبد ، البنكرياس والمرارة . يتم القيام بذلك بعد إعطائك دواء مهدئ يساعدك على الاسترخاء . سيطلب منك الاستلقاء على بطنك على الطاولة المخصصة لعمل الأشعة السينية . يقوم الطبيب بتمرير المنظار وهو عبارة عن أنبوب رفيع أسود اللون وشديد المرونة موصل بكاميرا تمكن الطبيب من رؤية صور مختلفة أثناء تمرير المنظار من فمك ، المريء ، المعدة والجزء الأول من الأمعاء الدقيقة . يتم تمرير أنبوب بلاستيكي رفيع من خلال المنظار إلى قنوات الكبد والبنكرياس . يتم حقن صبغة (الوسط المتباين) داخل هذه القنوات وتؤخذ لها صور . قد يقوم الطبيب خلال الإجراء بإزالة حصوات للتخلص من أي انسداد في القنوات . هذا الإجراء قد ، وقد لا يتطلب دواء تخدير مسكن .



2. هل سيكون هناك شعور بعدم الراحة ؟ هل هناك حاجة لأي دواء تخدير؟ هذا الإجراء قد لا يكون مريحاً ، ولجعله مريحاً قد يتم إعطائك حقنة مسكنة (مخدر خفيف) . قد يتم تحويل التخدير من مجرد إعطائك دواء مسكن إلى تخدير كلي . قبل بداية أي إجراء بالمنظار ، يقوم الطبيب بتركيب خط وريدي لك في اليد أو الساعد ويوصله بمحقنة . يتم حقن المسكن أو الدواء المخدر عن طريق هذا الخط الوريدي .

3. ماذا يعني التسكين (إعطاء دواء مسكن)؟ هو إعطاء دواء يعطيك شعور بالنوم ويجعلك مسترخ جداً خلال الإجراء ، حيث أن القيام بهذا الإجراء دون إعطاء مسكن قد يكون مزعج ومؤلم .

قد تكون لديك القدرة لتذكر بعض مما حدث أثناء القيام بالإجراء . التخدير بشكل عام آمن ، إلا أن كل دواء مخدر له مخاطره وآثاره الجانبية و مضاعفاته ، وعلى الرغم أن غالبيتها تكون مؤقتة ، إلا أن البعض منها قد تكون له مشاكل طويلة الأمد .

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

The risk to you will depend on:

- Personal factors, such as whether you smoke or/are overweight.
- Whether you have any other illness such as asthma, diabetes, heart disease, kidney disease, high blood pressure or other serious medical conditions.

4. What are the risks of this specific procedure?

There are risks and complications with this procedure. They include but are not limited to the following:

Common risks and complications include:

- About 10 people out of every 100 people will get swelling and inflammation of the pancreas (Pancreatitis). This may need pain relief. This usually settles over the next 24-48 hours. It can be severe and need further treatment, which may include treatment in ICU and/or surgery.
- Nausea and vomiting. Faintness or dizziness, especially when you start to move around.
- Headache.
- Pain, redness or bruising at the sedation injection site (either in the hand or arm).
- Muscle aches and pains.
- Allergy to medications given at time of the procedure.

Uncommon risks and complications include:

- Less than 1 person in every 100 will have a bleed as a result of the procedure. This can happen if a cut is made in the duct to remove a stone. This is usually stopped through the endoscope.
- About 1 person in every 100 will have a tear through the bowel or duct wall. This may require a drainage tube in your nose to remove the bile. This complication may sometimes require surgery.
- Bacteraemia (infection of the blood). This will need antibiotics.
- The procedure may not be able to be finished due to technical problems.
- Heart and lung problems such as heart attack or vomit in the lungs causing pneumonia.
- Emergency treatment may be necessary. Change of anaesthetic from a sedation anaesthetic to a general anaesthetic.
- 'Dead arm' type feeling in any nerve, due to positioning with the procedure – usually temporary.
- An existing medical condition that you may have getting worse.

Rare risks and complications include:

- Stroke resulting in brain damage.
- Anaphylaxis (severe allergy) to medication given at the time of procedure.
- Death as a result of complications to this procedure is rare.

المخاطر بالنسبة لك تتوقف على:

- عوامل شخصية مثل التدخين أو زيادة الوزن.
- إذا كنت مصاباً بأمراض أخرى كالربو الشعبي ، السكري ، مرض في القلب ، مرض في الكلى ، ارتفاع في ضغط الدم أو أي مشكلة طبية أخرى خطيرة.

4. ما هي مخاطر هذا الإجراء بالتحديد؟

لهذا الإجراء مخاطر ومضاعفات وتشمل ، ولكنها غير مقتصرة على :

مخاطر ومضاعفات شائعة وتشمل :

- تقريباً 10 أشخاص من كل 100 سوف يحدث لديهم تورم والتهاب في البنكرياس. قد يتطلب ذلك أدوية للألم وعادةً ما يختفي خلال 24-48 ساعة. وقد يكون شديداً ويتطلب علاجات أخرى والتي قد تشمل تلقي العلاج في وحدة العناية المركزة و/ أو الخضوع لجراحة.
- غثيان واستفراغ. إغماء أو دوخة خاصةً بعد البدء في ممارسة الحركة.
- صداع.
- ألم ، احمرار أو كدمة في موضع حقن المخدر (في اليد أو الذراع).
- أوجاع وآلم في العضلات.
- تفاعل تحسسي للأدوية التي أعطيت أثناء القيام بالإجراء.

مخاطر ومضاعفات غير شائعة وتشمل :

- أقل من شخص واحد في كل 100 سيعاني من نزف بسبب هذا الإجراء. قد يحدث ذلك إذا حصل قطع في القناة عند إزالة حصوة . يتم عادةً إيقاف النزف من خلال المنظار.
- عند تقريباً شخص واحد من كل 100 ، يحدث قطع في الأمعاء أو جدار القناة. قد يتطلب ذلك أنبوب تصريف من خلال الأنف لسحب مادة الصفراء التي يفرزها الكبد. قد يتطلب ذلك الجراحة أحياناً.
- بكتيريا في الدم (عدوى في الدم). يتطلب ذلك مضادات حيوية.
- عدم التمكن من إنهاء الإجراء بسبب مشاكل تقنية (فنية).
- مشاكل في القلب والرئة ، كالأزمة القلبية أو وصول المادة المستفرغة من المعدة إلى الرئة مسببة التهاباً رئوياً.
- الحاجة لمعالجة طارئة مما يتطلب تحويل التخدير من مجرد دواء مسكن إلى تخدير كلي.
- "الذراع الميت" شعور يحدث لأي عصب نتيجة تضرره بوضعية المريض أثناء الإجراء. عادةً يكون مؤقتاً.
- تفاقم أي مشكلة صحية أخرى يعاني منها المريض.

مخاطر ومضاعفات نادرة الحدوث وتشمل:

- سكتة دماغية ينتج عنها ضرر في المخ.
- الحساسية المفرطة (حساسية شديدة) بسبب الأدوية المعطاة أثناء الإجراء.
- الوفاة نادرة بسبب مضاعفات هذا الإجراء.

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

5. What are your responsibilities before having this procedure?

You are less at risk of problems if you do the following:

- Tell your doctor if you could be pregnant as X-rays are used as part of the procedure.
- Bring all your prescribed drugs, those drugs you buy over the counter, herbal remedies and supplements and show your doctor what you are taking.
- Tell your doctor about any allergies or side effects you may have.
- Do not drink any alcohol and stop recreational drugs 24 hours before the procedure.
- If you have a drug habit please tell your doctor If you take Warfarin, Persantin, Clopidogrel (Plavix or Iscover), Asasatin or any other drug that is used to thin your blood ask your doctor if you should stop taking it before the procedure as it may affect your blood clotting. Do not stop taking them without asking your doctor.

Tell your doctor if you have:

- had heart valve replacement surgery.
- received previous advice about taking antibiotics before a dental treatment or a surgical procedure.

6. Preparation for the procedure

You should not eat or drink anything for at least 6 hours before the procedure to make sure you have an empty stomach, which is necessary for a safe examination

7. What if the doctor finds something wrong?

Your doctor may take a biopsy (a very small piece of the bowel lining) to be examined at Pathology. Biopsies are used to identify many conditions even if cancer is not thought to be the problem.

8. What if I don't have the procedure?

Your symptoms may become worse and the doctor will not be able to give you the correct treatment without knowing the cause of your problems.

9. Are there other tests I can have instead?

Generally not. An MRI scan can be used to gather some information but cannot be used for treatment. Other treatment options include drainage under X-ray control and surgery.

10. What can I expect after this procedure?

- Usually you remain in the recovery area for about 2 hours until the effect of the sedation wears off.
- Your doctor will tell you when you can eat and drink. Most times this is straight after the procedure.
- You may experience bloating or pass wind because of the air introduced during the procedure.
- You will be told what was found during the examination or you may need to come back to discuss the results, and to find out the results of any biopsies that

5. ما هي مسؤولياتي قبل الخضوع لهذا الإجراء؟

ستكون أقل عرضة للمشاكل إن اتبعت التالي:

- أبلغني الطبيب إن كنت حاملاً لأنه يتم استخدام الأشعة السينية في هذا الإجراء.
- احضر معك كل الأدوية الموصوفة لك ، والأدوية التي تبتاعها دون وصفة ، والعلاجات العشبية والعلاجات التكميلية ، وأبلغ طبيبك بكل ما تتناوله منها.
- أبلغ طبيبك بكل أنواع الحساسية لديك وأي آثار جانبية قد سبق تعرضك لها.
- لا تحتسي الكحوليات وأوقف تعاطي كل الأدوية والعقاقير الترفيهية التي تتناولها ، وذلك قبل 24 ساعة من الإجراء.
- نرجو إبلاغ الطبيب إذا كان لديك تعود على أي دواء. إذا كنت تتناول أي من الأدوية التي تزيد من سيولة الدم كالوارفرين، بيرسنتن، كلوبيدوجريل (بلافيكس أو اسكوفير) أو اساسانتين أو أي عقار آخر لنفس الغرض ، فاسأل طبيبك إن كان عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء لأنها قد تؤثر على تخثر دمك. لا تتوقف عن تناولها دون مشاورة طبيبك.

أبلغ طبيبك إن كنت:

- قد خضعت لجراحة استبدال صمام في القلب.
- سبق وأن تم نصحك بتناول المضادات الحيوية قبل أي إجراء في الأسنان أو أي إجراء جراحي .

6. التحضير للإجراء

لا تتناول أي طعام أو شراب لست (6) ساعات قبل الإجراء للتأكد من خلو معدتك . هذا الأمر مهم لإجراء آمن.

7. ماذا لو اكتشف الطبيب وجود أمر مخالف للمألوف؟

قد يقوم الطبيب بأخذ خزعة (عينة) وهي جزء صغير جداً من الغشاء المبطن للأمعاء ليتم فحصها من قبل مختبر علم الأمراض. يستفاد من مثل هذه العينات في تشخيص العديد من الأمراض حتى لو لم يكن السرطان في الحسبان عند القيام بالإجراء.

8. ماذا لو لم أخضع للإجراء؟

قد تزداد الأعراض لديك سوءاً ولا يتمكن الطبيب من وصف العلاج الصحيح لك دون أن يكون على علم تام بسبب ما تعانيه من مشاكل.

9. هل بإمكانني الخضوع لأي اختبارات أخرى بديلة لهذا الإجراء؟

بشكل عام لا يوجد . يمكن استخدام التصوير بالرنين المغناطيسي للحصول على بعض المعلومات ، ولكن لا يمكن استخدامه في العلاج. من بدائل العلاج الأخرى استخدام الأشعة السينية في سحب المواد والعيّنات ، وكذلك الجراحة.

10. ما الذي يمكنني توقعه بعد هذا الإجراء؟

- عادةً ، تظل في غرفة الإفاقة لساعتين حتي ينتهي مفعول الدواء المسكن.
- سيبلغك طبيبك عن الوقت الذي يمكنك فيه تناول الطعام والشراب، وعادةً ما يكون ذلك مباشرة بعد الإجراء.
- قد تشعر بالانتفاخ وقد تخرج منك غازات بسبب الهواء الذي دخل أثناء الإجراء.
- قد يتم إبلاغك بنتيجة الفحص ، وقد يطلب منك العودة من أجل مناقشة ذلك في وقت آخر وللتعرف أيضاً عند نتائج فحص العينات

Patient's Name : _____

MRN : _____

DoB: _____

may have been taken.

- Your doctor may recommend dietary restrictions for 1- 2 days after the procedure.

11. What are the safety issues?

Sedation will affect your judgment for about 24 hours. For your own safety and in some cases legally:

- Do **NOT** drive any type of car, bike or other vehicle. You must be taken home by a responsible adult person.
- Do **NOT** operate machinery including cooking implements.
- Do **NOT** make important decisions or sign a legal document.
- Do **NOT** drink alcohol, take other mind-altering substances, or smoke. They may react with the sedation drugs.
- Have an adult with you on the first night after your surgery.

Notify the hospital Emergency Department straightaway if you have:

- Severe ongoing abdominal pain.
- A fever.
- Sharp chest or throat pain.
- Have redness, tenderness or swelling for more than 48hours where you had the injection for sedation (either in the hand or arm).
- Bleeding which can occur up to 3 weeks after the procedure. Symptoms of bleeding include
- Dizziness, fainting or passing blood or black bowel movements.

Notes to talk to my doctor about:

إن كانت قد أخذت.

- قد ينصح الطبيب بنظام غذائي محدد ليوم أو يومين بعد الإجراء.

11. ما هي الأمور المتعلقة بالسلامة؟

قد يؤثر الدواء المسكن لحوالي 24 ساعة على مقدرتك في اتخاذ القرار. لضمان سلامتك ولأخذ الأمور القانونية بعين الاعتبار:

- لا تقد أي نوع من المركبات كالسيارة أو الدراجة أو غيرها. يجب أن يرافقك إلى المنزل شخص عاقل بالغ ومسؤول عند خروجك من المستشفى.
- لا تقم بتشغيل أي آلات بما في ذلك أدوات الطهي.
- لا تتخذ أي قرار مهم ولا تقم بتوقيع أي مستند قانوني.
- لا تحتسي الكحول أو تتناول أي من المواد المسببة للهلوسة ، ولا تدخن . كل ذلك قد يتفاعل مع الدواء المسكن.
- استعن بشخص بالغ يظل بجوارك في الليلة الأولى بعد الإجراء.

قم فوراً بإبلاغ قسم الطوارئ في المستشفى إذا شعرت بـ :

- ألم شديد ومستمر في البطن .
- ارتفاع في درجة الحرارة.
- ألم حاد في الصدر أو الحلق.
- إذا كانت المنطقة التي تلقيت فيها إبرة الدواء المسكن (غالباً في اليد أو الذراع) حمراء ، مؤلمة عند لمسها أو متورمة لأكثر من 48 ساعة بعد الإجراء
- علامات النزيف الذي قد يستمر لثلاث أسابيع بعد الإجراء مثل : الدوخة، الإغماء ، خروج دم مع البراز (براز أسود).

أمور أتناقش حولها مع طبيبي:
